



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : حميده سيد عبد الباسط موسي

المحافظة : اسوان الحى / المدينة : ادفو

رقم البطاقة : 26806262800205 رقم التليفون : 01244971652

العمر (تاريخ الميلاد) : 26-06-1968 المهنة : ربه منزل

العنوان : ادفو

تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط اول تاموكسيفين قسم العلاج : [14160]
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

خطاب إداري

هذا الرقم القومي يتبع منظومة التأمين الصحي الشامل جهة الاختصاص



--

Name: حميدة سيد عبد الباسط موسى National ID: 26806262800205	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحديد الشخصية

حميدة
سيد عبد الباسط موسى
الرمادي قليس - ابوصادق
مركز ادفو - السوان

٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٢٠٥

IB2169115



139



Name: حميده سيد عبد الباسط موسي			
MR. : 7137			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحيه طيبه وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient presented today for continuation of tamoxifen therapy, with a plan for supportive treatment for an additional three months. The patient's breast cancer status is ER 0/8, PR 2/8, HER2 +3, currently on adjuvant tamoxifen initiated in February 2023. Imaging in July 2026 shows a BIRADS 1 assessment and an unremarkable ultrasound. The plan remains tamoxifen plus supportive care for three months, with the next visit scheduled for 17 October 2026.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :			
Reham Ahmed Fathy Ibrahim		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13003670
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 12/01/2023
Path No. : 110/2023	Verification Date : 24/01/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post chemotherapy.

Nature of the specimen: Left MRM specimen.

Gross Examination:

- Procedure: Left MRM specimen; measured 19x11x3 cm, covering skin measured 19x9 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.
- Localization: 2.5 cm lateral to the nipple
- Tumor extent
 - o Number: ill defined rubbery grayish white clipped TBS.
 - o Size: 1.5x1x1 cm.
 - o Skin involvement: 1 cm from skin
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 18 lymph nodes up to 1.3x1 cm.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A.

Microscopic examination:

- Histological type: Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, No viable tumor cells
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): N/A
- Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/18)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response
- Additional pathologic findings: Free nipple and areola

Diagnosis:

Verified by :
walaa ghoniem

Patient Name	: الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No.	: 13003670
Patient No.	: 26806262800205	Request Date	: 12/01/2023
Path No.	: 110/2023	Verification Date	: 24/01/2023
Sex	: Female	Financial Category	: نفقة الدولة - Out Patient
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Left breast cancer, post chemotherapy; Left MRM specimen:

- Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, with no residual viable tumor cells.
- Free nipple and areola
- Free surgical margins
- Free axillary lymph nodes (0/18)
- Pathologic complete response
- Stage= ypT0 ypN0

Prof.Dr. Eman Gouda
Dr. Heba Mostafa

Verified by :
walea ghoniem

Printing Date : 24/01/2023 13:46:57

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name	: الأستاذة / حميدة سعيد عبدالجاسط موسى	Request No.	: 13002661
Patient No.	: 26806262800205	Request Date	: 09/01/2023
Path No.	: 65/2023	Verification Date	: 15/01/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right intermediate lymph nodes

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 7-1-2023 (1:20 PM)

Gross Examination:

Multiple greyish white and fatty tissue cores up to 0.4 cm . Totally submitted .

Microscopic examination:

Histopathological examination of sections prepared from the lymph node biopsy received reveals cores of preserved normal nodal architecture. The subcapsular sinuses are patent. The lymph follicles are hyperactive and have prominent germinal centers, with dilated sinoids . There is no evidence of specific granuloma or neoplasia in sections examined.

Diagnosis:

Right intermediate lymph nodes , Tru cut biopsy:

- Consist with reactive hyperplasia
- No malignancy

Prof.Dr.Iman Gouda
Dr.Hebatallah mostafa

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 24/01/2023 11:13:31

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى
Patient No. : 26806262800205
Path No. : SR-540/22
Sex : Female
Age : 54 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001212
Request Date : 31/07/2022
Verification Date : 15/08/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Left breast mass & suspicious axillary lymph nodes

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 block (5579/22) + 1 block (6109/22) + 3 slides

Microscopic examination:

1- Breast:

* Histological type: DCIS with foci of Invasive duct carcinoma .

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II

*Angioinvasion: Positive

2-Lymph node

* Histological type:Metastatic adenocarcinoma of primary mammary ductal origin

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): G II

(3+2+1)

-IPT:

ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

PR: Weak nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 4/8)

Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)

Diagnosis:

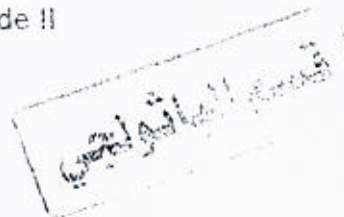
Left breast mass & suspicious axillary lymph node , slide revision :

1-Breast:

-DCIS with foci of Invasive duct carcinoma , grade II

2-Axillary Lymph nodes:

Verified by :
dr.esraa magdy



Printing Date : 15/08/2022 12:59:41

Page 1 of 2

Printing By : dr.esraa magdy



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 21/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Indication:

follow-up after Left MRM

Report:

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
 - Predominant Fatty parenchyma (ACR A)
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
21/01/2025 12:05 PM



Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

^{18}F FDG Whole Body PET/CT

Clinical Data:

- Female with newly diagnosed breast lump

Aim of the Study:

- Metastatic work-up.

Technique:

- Whole body ^{18}F -FDG images from skull to mid thighs with the arms extending above the head were obtained.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction. IV contrast was administered.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.

Review of PET, CT and fused images revealed:

Head and Neck:-

- The brain appears normal on CT, with no abnormal focal metabolic activity detected.
- Few prominent submandibular and deep cervical lymph nodes, the largest reaching about 1.3 cm seen at the left submandibular group.
- Large metabolically active left thyroid lobe well defined isodense enhancing nodule, measuring about 2x1.8 cm with SUV max 10. Smaller ill defined INACTIVE nodules are seen within the right lobe and isthmus, for further US correlation.

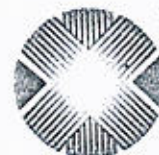


- Physiologic radiotracer uptake is demonstrated at the oropharynx, larynx, thyroid and salivary glands.
- Normal FDG uptake pattern is seen at the soft tissues of the neck.

Chest:

- Dense fibroglandular texture of the left breast, showing ill defined speculated lesion associated with tiny calcific focus is seen within the outer lower quadrant of the left breast roughly measuring about 3x1.5 cm. It shows LOW

Imaging report



CAIRO SCAN
Radiology & LRS

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa
Date : 21/08/2022

Code : R2751741

grade FDG uptake with SUV max 1.8. Also seen few small clustered nodular opacities seen within the lower outer quadrant inferior to the prior lesion, the largest measures about 1 cm, also noted.



- Enlarged left axillary lymph nodes, the largest reaching about 3x1.3 cm with Mild FDG uptake and SUV max 3.3



- Solitary pulmonary nodule is seen at the medial segment of the middle lobe measuring about 8 mm
- No pleural or pericardial collections.
- Enlarged aortopulmonary lymph node, measuring about 12 mm, otherwise No metabolically active or pathologically enlarged axillary, supra-clavicular, hilar or mediastinal lymph nodes could be detected.
- Normal tracer biodistribution is noted at the myocardium and great vessels.

Abdomen and Pelvis:

- Liver is of average size, showing homogenous texture and smooth outline.
- No hepatic focal lesions or areas of abnormal enhancement or metabolic activity.
- No biliary radicles dilations could be noted.
- Large GB stones
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, both kidneys, aorta and IVC as well as pelvic organs
- Normal FDG activity is seen at the gastrointestinal and genitourinary systems, with no striking focal hypermetabolic lesions detected.
- No pathologically enlarged or metabolically active abdominal or pelvic lymph nodes.

Imaging report



CAIRO SCAN
Imaging & Lab

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

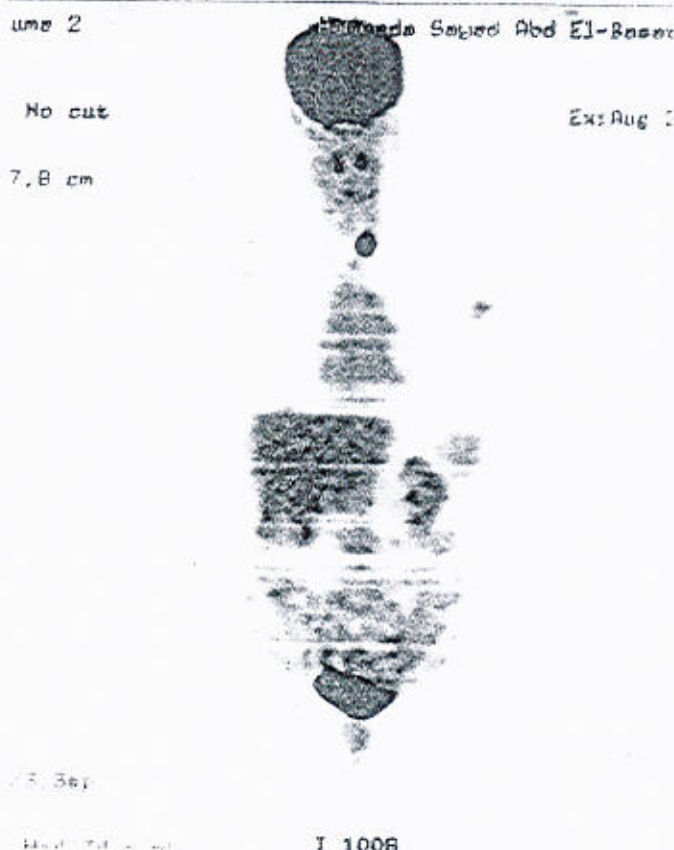
Date : 21/08/2022

Code : R2751741

- No ascites.

Musculo-skeletal:

- FDG biodistribution is rather physiologic, with no significant FDG avid blastic or lytic skeletal lesions could be detected.



OPINION :

Left breast nodule(s) with very LOW grade metabolic activity for further correlation with mammography and histopathology.

FDG avid left axillary LNs likely metastatic.

FDG avid left thyroid lobe nodule for FNAC to exclude malignancy that is highly suggested.

BEST REGARDS;

DR. AHMED ZAHER , M.D. **PROF.HAMED EL-GHAWABY**
PROF. OF NUCLEAR MEDICINE , NCI ,
CAIRO UNIVERSITY

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on

radreport@cairoscan.com.eg



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 54 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

**** known case of breast cancer:**

Findings:

- Bilateral few pulmonary nodules the largest is noted in the lower left lung lobe measuring about 10 mm.
- Bilateral basal and lingular atelectatic bands associated with bilateral basal sub pleural reticulations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts show Calcular gallbladder.
- Enlarged thyroid gland, for dedicated US study.

OPINION:

- ***Bilateral few pulmonary nodules of indeterminate nature for follow up.***



مبادرة رئيس الجمهورية
لحماية صحة المرأة المصرية

الوزارة
القاهرة
مصر

MDT FORM

24721 / 2023 G B

Name	عبدالله محمد	MRN	6789 54321
Age	54	ID	CC - 54321
Menopausal status		Phone	1155 971705
NRS SCORE		Marital status	1.98 19/19
BMI		Family history	
CO morbidity	Post NACT	REASON OF MDT	Post 1 + MRM

Clinical Data

BX: IDC: Margins: free LN: 0/18 - NAC: free			
ER: 0/3	PR: 2/8	HER 2: +3	Ki67: -
Sonomammography:			
Mets Workup: PET CT → free			

R Pathological Complete Response



pT0N0M0

Signature
C.C. / 1/18

Recommendations: patient Ease + post NACT
- Post MRM
- Previous It axillary LN removed with multi-contrast disc
STEP → MRM → CRF → MDT

MDT OUTCOME & PLAN

for PORT / Compl
/ N wadex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Signature 7/12/2023		Signature 7/12/2023			

Signature



شؤون كينون في وزارة الداخلية
بطاقة تحقيق المذمة

حميده

سيد عبد الباسط موسى

الرمادي قبلي - ابو صديق

مركز الفو - اسوان

١٩٦٨/٠٩

٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٠٢٠٥

LY2794276

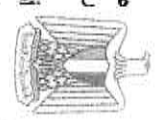


٢٠٢٦/٠٩ ٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٢٠٥
ريه منزل

مقروجة مسلمة انشي

محمد صالح محمد حسين

البطاقة سريرية حتى ٢٠٣٣/٠٨/٣١



HEALTH INSURANCE

UHIA

إدارة خدمة العملاء



عاملة للتأمين الصحي الشامل
فرع أسوان
؛ العامة لشئون المستفيدين

736	رقم مسلسل
مستشفى جوستاف روسي الدولي - أورايم دار السلام هرميل	السيد الدكتور / مدير
حميدة سيد عبدالباسط موسى	قادم لسبب انكم السيد /
الرمادي قبلي - ابو صديق مركز القفر	العنوان
ربه منزل	جهة العمل
25806122800139	الرقم القومي لعائل الأسرة
26806262800205	الرقم القومي لطالب الخدمة
01120709869	رقم هاتف التواصل
58 أعوام / أنثى	السن / النوع
2640	رقم التأمين الصحي
وحدة الفوالية	الوحدة التابع لها
غير معروف	طبيب الأسرة
غير معروف	الطبيب / مصدر التقرير الطبي
وكرم خبيث بالثدي	تشخيص
مزمين	نوع التشخيص : مزمين / غير مزمين
تحتاج إلى استكمال العلاج الهيرموني (تاموفين) والعلاج التجمعي مع عمل الفحوصات والاشعاعات والتحليل اللازمه لمدة 3 اشهر من تاريخ اصدار الخطاب مع الاقرارام بتنفيذ الاجراءات ذات صلة بالبروتوكول	الخدمة المطلوبة ؟
-	تاريخ الدخول
-	تاريخ الخروج
لا	هل تحتاج لموافقة مسبقة ؟
لا	هل تحتاج لموافقة استثنائية ؟
طبقا لأسعار المحافظة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع أسوان	سعر الخدمة

تم تحصيل المساهمة بإصدار رقم (بتاريخ)
يرجاء قبول الحالة وذلك على حسب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع أسوان

مع الاقرارام بتنفيذ الاجراءات ذات صلة بالبروتوكول

مدير الإدارة العامة لشئون المستفيدين/
مدير إدارة خدمة العملاء

الطبيب المراجع

الموظف المختص

الاسم / التاريخ

الاسم / التاريخ

الاسم / احمد مدحت عبد المطلب

ختم الإدارة

الاسم / التاريخ

الاسم / احمد مدحت عبد المطلب

تحرير افي : 2026-09-15

يرفق رقم الحساب للمداد / رقم تلفون للتواصل

الخطاب صالح لمدة (14) أربعة عشر يوما من تاريخه يرفق رقم الحساب للمداد / رقم تلفون للتواصل
يرفق عند تقديم المطالبة نتائج التحليل والاشعاعات والتقرير الطبية

712V

Patient Name Hamed a sayed	Date : 25/07/2026
Exam : Ultrasound ABDOMEN& PELVIS	

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver:-

- AVERAGE SIZED 14CMat Rt MCL)homogenous parenchymal echo pattern
- No IHBRD seen
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder:-

Contracted and cannot be properly visualised
CBD normal

Spleen:-

- Normal size 9 cm, homogenous texture with no focal lesions

Kidneys:-

- Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.
- No stones , no back pressure changes

Para-aortic and pancreatic area: concealed by gaseous distention

Urinary Bladder:-

- Minimally Filled with no stones or masses

Opinion:

Unremarkable study

Patient's Name:

Hamida Said Abdelbasel Mousa

Date:

2026-07-25

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt



Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM , routine follow up.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

٢٩٢٢
٢٠٢٢

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



حميدة
سميرة عبدالباسط موسى
الرمادي قبلي - ابوصديق
مركز ادفو - اسوان

٢ ٦٨ ٠ ٦ ٢٦ ٢٨ ٠ ٠ ٢ ٠ ٥

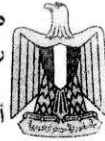
IB2169115





٢٠١٩/٠٧ ٢٦٨ ٢٢٦٢٨٠٠٠٢٠٥

ربة منزل

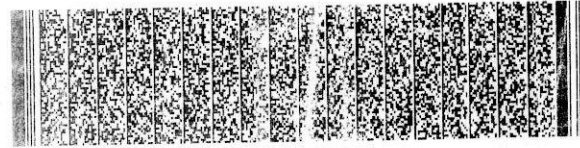


أنثى مسلمة متزوجة

محمد صالح محمد حسين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٧/١٥

٤





83086292 MDT FORM 23 / 8 / 2022 G

Name	حميدة سيد عبدالباسم	MRN	٢٠٢٢ - ٢٩ ٢٣
		ID	٢٦٨٠٦٢٦٢٨٠٠٠٠
Age	54	Phone	١١٤٤٩٧١٦٢
Menopausal status	perimenopausal	marital status	Married
NRS SCORE	one	Family history	-ve
BMI	24 → Normal	REASON OF MDT	-
Co morbidity	D- HTN		

Clinical Data

Bx:	IDC II			R	L
ER:	0/8	PR:	3/8	HER 2:	+ve
				Ki67:	
<u>Sonomammography:</u> ① Mamma 3 o'clock 1,5 ② Mass					
<u>Mets Workup:</u> CTs → iliac bone / Lung ?? bone lesion. / Thyroid Bone → Indeterminate				T N M	
12/8 PET/CT → Free					

Recommendations:

pt is not metastatic
PET -ve

MDT OUTCOME & PLAN

Pr T₁CHP 6 cycles, FNA from
Thyroid nodule → Benign Follicular (Bethesda II)

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	psychiatric

23/8/2022
Angilsh 23/8/2022



Post OP ٢٠٢

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الست المصرية
صحة
مصر

MDT FORM

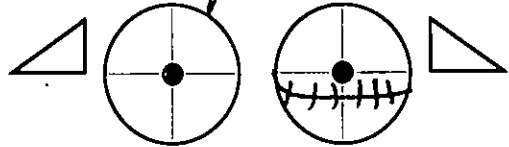
24/2/2023 G B

Name	عبد الوهاب	MRN	C7N957CA...
Age	54	ID	C.CC - C7CA
Menopausal status		Phone	115591705
NRS SCORE		Marital status	1.99 19/19.
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	Post 1st MRM

Clinical Data

BX: DC: Margins: free LN: 0/18 - NAC: free			
ER: 0/3	PR: 2/8	HER 2: 43	Ki67: -
Sonomammography:			
Mets Workup: PET CT → free			

R Pathological Complete Response



pT₀N₀M₀

C.C. / 1/CE

Recommendations: patient Case to Post NACT
- Postoperative MRM
- previous axillary LN Present with multicentric disease
STEP → MRM → CR For MDT

MDT OUTCOME & PLAN

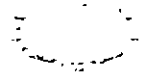
for PORT / complete
/ Nivada

Yes Monitor/psych

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
SP 7/2/23		Amal 7/2/23			

Amal



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13003670
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 12/01/2023
Path No. : 110/2023	Verification Date : 24/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, post chemotherapy.

Nature of the specimen: Left MRM specimen.

Gross Examination:

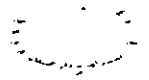
- Procedure: Left MRM specimen; measured 19x11x3 cm, covering skin measured 19x9 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.
- Localization: 2.5 cm lateral to the nipple
- Tumor extent
 - o Number: Ill defined rubbery grayish white clipped TBS.
 - o Size: 1.5x1x1 cm.
 - o Skin involvement: 1 cm from skin
- Distance from margins: 1 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: 18 lymph nodes up to 1.3x1 cm.
- Additional pathologic findings: N/A
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section: N/A.

Microscopic examination:

- Histological type: Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, No viable tumor cells
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): N/A
- Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/18)
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response
- Additional pathologic findings: Free nipple and areola

Diagnosis:

Verified by :
walaa ghoniem



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالجاسط موسى	Request No. : 13003670
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 12/01/2023
Path No. : 110/2023	Verification Date : 24/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

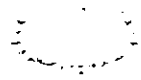
Pathology Report

Left breast cancer, post chemotherapy; Left MRM specimen:

- Pathologic complete response in previously diagnosed duct carcinoma, with no residual viable tumor cells.
- Free nipple and areola
- Free surgical margins
- Free axillary lymph nodes (0/18)
- Pathologic complete response
- Stage= ypT0 ypN0

Prof.Dr. Eman Gouda
Dr. Heba Mostafa

Verified by :
walaa ghoniem



Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13002661
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 09/01/2023
Path No. : 65/2023	Verification Date : 15/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right intermediate lymph nodes

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy collected 7-1-2023 (1:20 PM)

Gross Examination:

Multiple greyish white and fatty tissue cores up to 0.4 cm . Totally submitted .

Microscopic examination:

Histopathological examination of sections prepared from the lymph node biopsy received reveals cores of preserved normal nodal architecture. The subcapsular sinuses are patent. The lymph follicles are hyperactive and have prominent germinal centers, with dilated sinoids . There is no evidence of specific granuloma or neoplasia in sections examined.

Diagnosis:

Right intermediate lymph nodes , Tru cut biopsy:

- Consist with reactive hyperplasia
- No malignancy

Prof.Dr.Iman Gouda
Dr.Hebatallah mostafa

Verified by :
dr.esraa magdy

Patient Name : الأستاذة / حميدة سيد عبدالباسط موسى	Request No. : 13001212
Patient No. : 26806262800205	Request Date : 31/07/2022
Path No. : SR-540/22	Verification Date : 15/08/2022
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report**Clinical Data:**

Left breast mass & suspicious axillary lymph nodes

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 block (5579/22) + 1 block (6109/22) + 3 slides

Microscopic examination:**1- Breast:**

* Histological type: DCIS with foci of Invasive duct carcinoma .

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II

*Angioinvasion: Positive

2-Lymph node:* Histological type: Metastatic adenocarcinoma of primary mammary ductal origin

* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): G II

(3+2+1)

-IPT:

ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)

PR: Weak nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 4/8)

Her-2: strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Diagnosis:

Left breast mass & suspicious axillary lymph node , slide revision :

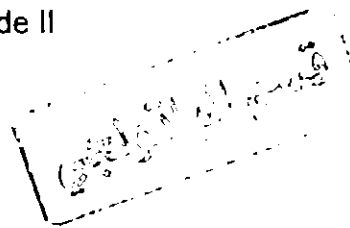
1-Breast:

-DCIS with foci of Invasive duct carcinoma , grade II

2-Axillary Lymph nodes:

Verified by :

dr.esraa magdy



	Med. Record No.:	2022195618
	Patient Name:	HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA
	Sex:	Female DOB: 6/26/1968
	Nationality:	EGYPTIAN
	Unit:	External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis

Hormone receptors

Specimen Id	2207230370	Sample Type	Paraffin Block
Accession No	IMM22-4839	Requesting Doctor	Abd ALLAH Mohamed Gamil
Collection Date	7/23/2022 12:39:21PM		
Receive Date	7/23/2022 12:39:32PM		

Immunohistochemical Report

pathology number

6109/22

Clinical Data

LT axillary l.node metastatic carcinoma.

Gross Picture :

[Referred block submitted for ER/PR Immunostaining.]

System Used :

[Ventana BenchMark ULTRA autostainer.]

Antibody:

[Ventana anti-PR(1E2) Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER(SP1) Rabbit monoclonal antibody.]

Scoring system :

According to the ASCO/CAP guideline update, 2019 : Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive. Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, <1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%–100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8. Comment: - There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expressers (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and their potential benefit from endocrine therapy. - PR positive in 1-20% of tumor cells is considered as Low positive.

(Laterality) breast Cancer:

[left]

Diagnosis :

LT axillary l.node metastatic carcinoma:

ER :Negative, weak nuclear reaction in <1% of tumor cells (2/8).

PR : Low positive, weak nuclear reaction in 10% of tumor cells (3/8).

Signature

[MAHITAB IBRAHIM MOHAMED PHD]

	Med. Record No.:	2022195618
	Patient Name:	HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA
	Sex:	Female DOB: 6/26/1968
	Nationality:	EGYPTIAN
	Unit:	External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis
Her2 Receptors

Specimen Id	2207230371	Sample Type	Paraffin Block
Accession No	IMM22-4840	Requesting Doctor	Abd ALLAH Mohamed Gamil
Collection Date	7/23/2022 12:39:28PM		
Receive Date	7/23/2022 12:39:36PM		

Immunohistochemical Report

pathology number
6109/22

Clinical Data
LT axillary l.node metastatic carcinoma.

Gross Picture :
[“Referred block submitted for HER 2 Immunostaining.”]

System Used :
[“Ventana BenchMark ULTRA autostainer.”]

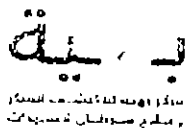
Antibody:
[“Ventana anti-HER-2 (4B5) rabbit monoclonal antibody.”]

Scoring system :
Reference: ASCO–CAP HER2 Test Guideline Recommendations, 2018. IHC 0 :as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within <=10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within >10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: The revised definition of IHC 2+ (equivocal) is weak to moderate complete membrane staining observed in >10% of tumor cells.. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense in >10 % of tumor cells.

Laterality - 1
[“Left”]

Her2 Result - 1
[“Positive [score 3+]”]

Signature
[“MAHITAB IBRAHIM MOHAMED PHD”]



Med. Record No.: 2022195618
Patient Name: HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA
Sex: Female DOB: 6/26/1968
Nationality: EGYPTIAN
Unit: Oncology Surgery

SURGICAL PATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis**Biopsy Small - (1 Site)**

Specimen Id 2206260503

Sample Type

Tissue

Accession No SUR22-5579

Requesting Doctor

Ibrahim Adel Mohamed Shaker

Collection Date 6/26/2022 6:55:51PM

Receive Date 6/26/2022 6:55:57PM

Clinical Information

Left breast 3:00 highly suspicious lesion (BIRADS 5), with pathologic axillary l. node

Gross Picture

Multiple cores 0.7-1.2 cm, totally embedded.

Microscopic Picture

A case of ductal carcinoma insitu (solid pattern), high grade. Stroma is desmoplastic with dense lymphoid infiltrate.
There are two foci stromal microinvasion (1mm) in the current material.

Diagnostic Summary**Tumour type:**

Ductal carcinoma insitu, high grade with foci of stromal microinvasion

Laterality

[Left]

Specimen type:

U/S guided Tru-cut biopsy.

Diagnosis

Left breast, Tru-cut biopsy:

Ductal carcinoma insitu, high grade with foci of stromal microinvasion.

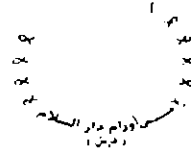
N.B: Tissue biopsy from the described pathologic l. node is recommended to assess invasiveness and HER2 status assessment.

Signature

[Heba Abdallah]

Co-signed by:

[Dr. Ghada M. Abdelsalam, MD]



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 13/12/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM.

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

13/12/2023 11:07 AM



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 13/12/2023
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *Enlarged in size (16.8cm at Rt MCL) bright parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- *Average distention and capacity with multiple large stones seen inside*
- *The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

Average size , homogenous.

Kidneys: -

- *Both are average in size, shape and echogenicity*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

Para-aortic and pancreatic area: *show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

empty

Opinion:

*Bright hepatomegaly likely fatty
Calcular GB*

Signature Dr . Nermien Ramadan
PM 12:31 2023/12/13



٢٩٢٢
٢٢

٢٩٢٢ / ٤ / ١١
/٢ حميد عبد الله الباسط **Echo report**

Name:

Date: 13/4/2023

EF	63%	55-75%	PWT		0.6-1.1cm
LVEDD	5.1	3.5-5.8cm	AO.R	3.1	2-3.7cm
LVESD	3.4	2-4cm	LA	3.2	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function ~~DD~~ GI

SWMA No RWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion No

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology

PATIENT NAME: HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA	PATIENT ID #: 2022195618
GENDER: Female	ORDER #: 1694319,1695542
AGE: 54 y	DATE OF SERVICE: 26-Jun-2022 02:22 PM

26/6

Clinical indication - all studies

Left breast highly suspicious mass

Report: - all studies

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO view.
- Targeted ultrasound

REPORT:

- Both breasts show heterogeneous fibroglandular densities (ACR c).

LEFT BREAST:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate background parenchymal enhancement with heterogeneously enhancing lesions are seen nearly at 3:00, the largest measuring about 2.7x1.2cm in diameter, targeted Ultrasound revealed corresponding two micro-lobulated lesions at 3:00, measuring about 2x0.8cm and 1x0.5cm in diameter respectively.
- Small faint enhancing nodules are noted 9:00 and 12:00, targeted ultrasound revealed corresponding small indistinct hypoechoic nodule located at 9:00, measuring about 5x4mm in diameter.

RIGHT BREAST:

- No spiculated mass lesions or microcalcific clusters.
- Contrast Enhanced Spectral Mammography showed moderate background parenchymal enhancement with no significant enhancing lesions.
- Normal nipple areola complexes.

OPINION:

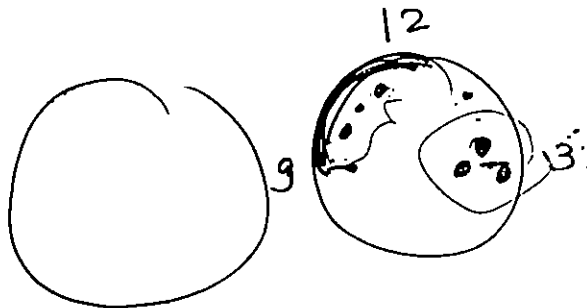
- Left breast 3:00 highly suspicious lesions along with 9:00 and 12:00 suspicious enhancing nodules suggesting multicentric malignant process (BIRADS 5).
- No right breast pathological enhancement (BIRADS 2).

Recommendation - all studies

Reported By,

Dr Lobna KHALED.MD

26-Jun-2022 03:54 PM





Echo report

Name:

Date : 1 / 1 / 2023

MR ٢٢ / ٢٩٢٢

EF	61.1	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.4	3.5-5.8cm	AO.R	2.3	2-3.7cm
LVESD	2.9	2-4cm	LA	3.1	2-4cm
FS	32	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

— systolic function with — internal dimension EF 61%
imp diastolic function. grade I.

— LA and Ao root dimensions.

— Mitral Valve morphology

No resting SWMA.

— Aortic valve morphology

— Tricuspid valve morphology and leaflets

Normal Pulmonary Valve.

No intrcardiac masses or pericardial effusion

Conculsion: Diastolic dyf grade I.

—

Dr. Mohamed A. Wahab

Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/11/2022
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Post NACT status assessment of a known left breast malignant mass

Report:

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma of both breasts
- Left breast:
 - UOQ faint grouped microcalcifications with clip is seen inserted insitu. Ultrasound shows no underlying definite lesions.
 - Left axillary (level I and II) pathological lymph nodes are still seen.
 - No supraclavicular lymph nodes.
- Right breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - **Indeterminate right enlarged axillary LN with uniform increase of cortical thickness reaching about 4.3 mm.**

Opinion:

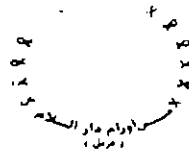
- Post NACT status of left breast showing complete radiological response of the previously noted malignant mass with pathological level I and II axillary lymphadenopathy (BIRADS 6)
- Right indeterminate axillary lymph nodes.
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr/Asmaa Zeinhom, Msc

Signature Temp

10/11/2022 2:00 PM



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 21/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 56 Year(s)
Medical ID: 2923/2022	Pat. ID: 22983

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Indication:

follow-up after Left MRM

Report:

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
 - Predominant Fatty parenchyma (ACR A)
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University
21/01/2025 12:05 PM

PATIENT NAME: HAMEDA SAYED ABDELBASET MOSA	PATIENT ID #: 2022195618
GENDER: Female	ORDER #: 1744752,1744753
AGE: 54 y	DATE OF SERVICE: 26-Jul-2022 03:07 PM

Report: - all studies

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS**

1- CHEST:

- Left breast UOQ irregular spiculated mass lesion measuring 20 X 13 mm.
- Enlarged left axillary level I and II lymph nodes the largest measures 32 X 13 mm.
- Few bilateral pulmonary nodules the largest is seen at medial segment of middle lung lobe measuring 9 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormalities. No pericardial effusion detected.
- Left thyroid hypodense nodule.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calcular gall bladder.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenal glands.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 54 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

**** known case of breast cancer:**

Findings:

- Bilateral few pulmonary nodules the largest is noted in the lower left lung lobe measuring about 10 mm.
- Bilateral basal and lingular atelectatic bands associated with bilateral basal sub pleural reticulations.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- No sizable osseous lytic or sclerotic lesions in the scanned skeleton.
- Upper abdominal cuts show Calcular gallbladder.
- Enlarged thyroid gland, for dedicated US study.

OPINION:

- ***Bilateral few pulmonary nodules of indeterminate nature for follow up.***



Patient Name: Hmida Sayed Abd Al Baset Mousa	Date : 10/01/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 54 Year(s)
Medical ID:	

- ***Bilateral basal and lingular atelectatic bands associated with bilateral basal sub pleural reticulations , likely post inflammatory sequel.***
- ***Calcular gallbladder.***

Dr. Mohammed Mahjoub

Dr. *M. Gomaa*, M.D.



٢٩٢٢

٢٢

وزارة الصحة والسكان
امانة المستشفى الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

حسينه سيد عبد الباقى / **Echo report**

Name:

Date: 7/4/2023

EF	63%	55-75%	PWT		0.6-1.1cm
LVEDD	5.1	3.5-5.8cm	AO.R	3.1	2-3.7cm
LVESD	3.4	2-4cm	LA	3.2	2-4cm
FS	34%	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function ~~DD~~ GI

SWMA No RWMA at rest

LA and Aortic root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

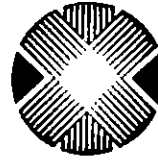
Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion No

D/ Mohamed Ali

Msc cardiology



Imaging report

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

^{18}F FDG Whole Body PET/CT

Clinical Data:

- Female with newly diagnosed breast lump

Aim of the Study:

- Metastatic work-up.

Technique:

- Whole body ^{18}F -FDG images from skull to mid thighs with the arms extending above the head were obtained.
- CT was acquired for the purpose of anatomic localization and attenuation correction. IV contrast was administered.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.

Review of PET, CT and fused images revealed:

Head and Neck:-

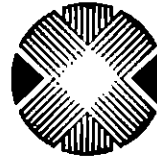
- The brain appears normal on CT, with no abnormal focal metabolic activity detected.
- Few prominent submandibular and deep cervical lymph nodes, the largest reaching about 1.3 cm seen at the left submandibular group.
- Large metabolically active left thyroid lobe well defined isodense enhancing nodule, measuring about 2x1.8 cm with SUV max 10. Smaller ill defined INACTIVE nodules are seen within the right lobe and isthmus, for further US correlation.



- Physiologic radiotracer uptake is demonstrated at the oropharynx, larynx, thyroid and salivary glands.
- Normal FDG uptake pattern is seen at the soft tissues of the neck.

Chest:

- Dense fibroglandular texture of the left breast, showing ill defined speculated lesion associated with tiny calcific focus is seen within the outer lower quadrant of the left breast roughly measuring about 3x1.5 cm. It shows LOW



Imaging report

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

grade FDG uptake with SUV max 1.8. Also seen few small clustered nodular opacities seen within the lower outer quadrant inferior to the prior lesion, the largest measures about 1 cm, also noted.



- Enlarged left axillary lymph nodes, the largest reaching about 3x1.3 cm with Mild FDG uptake and SUV max 3.3



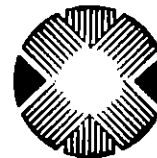
- Solitary pulmonary nodule is seen at the medial segment of the middle lobe measuring about 8 mm
- No pleural or pericardial collections.
- Enlarged aortopulmonary lymph node, measuring about 12 mm, otherwise No metabolically active or pathologically enlarged axillary, supra-clavicular, hilar or mediastinal lymph nodes could be detected.
- Normal tracer biodistribution is noted at the myocardium and great vessels.

Abdomen and Pelvis:

- Liver is of average size, showing homogenous texture and smooth outline.
- No hepatic focal lesions or areas of abnormal enhancement or metabolic activity.
- No biliary radicles dilatations could be noted.
- Large GB stones
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, adrenals, both kidneys, aorta and IVC as well as pelvic organs
- Normal FDG activity is seen at the gastrointestinal and genitourinary systems, with no striking focal hypermetabolic lesions detected.
- No pathologically enlarged or metabolically active abdominal or pelvic lymph nodes.



Imaging report



كايرو سكات
للأشعة والتخيل
CAIRO SCAN
Radiology & IAS

Name : Mrs. Hameeda Sayed Abd El-Basat Mousa

Date : 21/08/2022

Code : R2751741

- No ascites.

Musculo-skeletal:

- FDG biodistribution is rather physiologic, with no significant FDG avid blastic or lytic skeletal lesions could be detected.

une 2

Hameeda Sayed Abd El-Basat

No cut

Ext Aug 2

7.8 cm

/3.3ep

M-1 7.8 1.21

I 1008

OPINION :

Left breast nodule(s) with very LOW grade metabolic activity for further correlation with mammography and histopathology.

FDG avid left axillary LNs likely metastatic.

FDG avid left thyroid lobe nodule for FNAC to exclude malignancy that is highly suggested.

BEST REGARDS;

DR. AHMED ZAHER , M.D. PROF.HAMED EL-GHAWABY
PROF. OF NUCLEAR MEDICINE , NCI ,
CAIRO UNIVERSITY

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on

radreport@cairoscan.com.eg



119

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام

حميدة

اسم المريض رباعي :
رقم الملف الطبي :
نوع الوجبة :
تاريخ اعداد الوجبة :
وقت اعداد الوجبة :

port

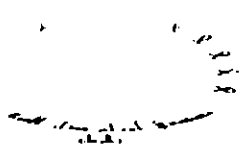
وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام

EF	62	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDL	5.4	3.5-5.8cm	AO.R	3.1	2-3.7cm
LVESL	3.6	2-4cm	LA	3.5	2-4cm
FS	34	25-45%	RV	normal	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP	normal	1.5-2.6cm

LV dimensions *normal*LV wall thickness *normal*LV diastolic function *6 I D D.*SWMA *normal*LA and Aortic root dimensions *normal*Mitral Valve *thicker e' Trivial MR*Aortic valve: *normal*Tricuspid valve *normal e' Trivial TR, normal RVIP.*Pulmonary valve *normal*Right side and systolic function *normal*Intracardiac masses and effusion *normal*

D mohammed Anwar

Msc cardiology



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

Patient ID:

Name : حميد سيد عبدالمطلب موسى

Sex:

3- Medical number:

Female

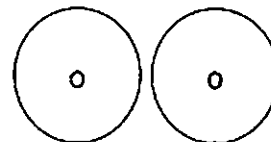
83086292

Old Med :

2923/2022

ID number: 26806262800205

Patient Age : 55 Y



Family history

-VE

Phone

01099198190

BMI

wt = 68 kg

ht = 160 cm

BMI = 26

REASON OF MDT

POST NACT

marital status

NRS Score

1

GROUP

Date of MDT

01/07/2023

Co morbidity

DM ON OHGS,,

marital status

MARRIED

Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

PETCT-->FREE

BX:

LT IDC GII WITH
DCIS WITH FOCI
8/22

IHC:

ER:

0/8

PR:

4/8

Her 2 Neu :

+VE

KI67 :

T

N

M

Sonomammography

CESM--> LT BREAST MASS AT 3 O'CLOCK 2.7X1.2+ 2 MICRO LOBULATED LESIONS 2X.8CM
1X.5 CM

Recommendations:

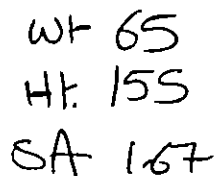
THE CONDITION STARTED IN 2022 BY LT AXILLARY LN ACCIDENTALLY DISCOVERED
SHE ENDED NACT TCX18 WKS LAST ONE ON 22/12/2022,,,HP X6 LAST ONE ON 29/12/22

MDT OUTCOME & PLAN

FOR LT MRM (multicentric&ycN1) after FNAC of contra-lateral indeterminate axilla

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	



Age: 54
ABW: 54.7
Srcr: 0.8
CrCl: 69.4

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
هرمل ، سابقا
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Ex. 65-1 on 1618

اسم المريض :

الرقم الطبى :

الأوامر

chest:

Temp: _____

Oral mucositis:

Canula site infection.

* C10: - Epigastric pain.

- Mild Nausea.

- Baseline Bilat. LL Neuropathy, G.I
"Diabetic"

* For: C/W2 Taxes 123mg
Carbo. AVE 12

→ Today: $\boxed{\text{carbo: } 189 \text{ mg}}$
april 11/19

- C₁ v₃ Taxi 123 mg

Carbo-AUC [21] on 0.710000 - Carbo: 189
 111 1 89
 111 1 89

- H/P is still pending. قرار

- FNA from Thyroid nodule is done ~~depending~~ ^{pending} results.

توقيع الطبيب: د. كاترين Controlloc 40mg • التاريخ: 19/11/2022

الوقت: Ondansetron 8mg Patch 4x2x7 days

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection

18-9-2022

CBCK

C₂H₄ Toluol/Carbo:

C. F. P.

15/9/2022

Cr 20.9

Carbo. 173 mg

C₂H₂TC [173mg]

C. ph 1Abeor
22/9/2022

التاريخ

الوقت:

توقيع الطبيب :

C.C. 104/56

2020

اسم المريض رباعي: محمد بن عبد الله
 الرقم الطبي الموحد:

2923/22

Doctor's Orders الأوامر الطبيب

التشخيص: نوع التغذية:

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
		29.19.2022 K₂W₃ T_{axel} (1000mg) 9/19 4/19 1/19 4/19 8/19 12/19 1/20 4/20 8/20 12/20 1/21 4/21 8/21 12/21 1/22 4/22 8/22 12/22 1/23 4/23 8/23 12/23 1/24 4/24 8/24 12/24 1/25 4/25 8/25 12/25 1/26 4/26 8/26 12/26 1/27 4/27 8/27 12/27 1/28 4/28 8/28 12/28 1/29 4/29 8/29 12/29 1/30 4/30 8/30 12/30 1/31 4/31 8/31 12/31 1/32 4/32 8/32 12/32 1/33 4/33 8/33 12/33 1/34 4/34 8/34 12/34 1/35 4/35 8/35 12/35 1/36 4/36 8/36 12/36 1/37 4/37 8/37 12/37 1/38 4/38 8/38 12/38 1/39 4/39 8/39 12/39 1/40 4/40 8/40 12/40 1/41 4/41 8/41 12/41 1/42 4/42 8/42 12/42 1/43 4/43 8/43 12/43 1/44 4/44 8/44 12/44 1/45 4/45 8/45 12/45 1/46 4/46 8/46 12/46 1/47 4/47 8/47 12/47 1/48 4/48 8/48 12/48 1/49 4/49 8/49 12/49 1/50 4/50 8/50 12/50 1/51 4/51 8/51 12/51 1/52 4/52 8/52 12/52 1/53 4/53 8/53 12/53 1/54 4/54 8/54 12/54 1/55 4/55 8/55 12/55 1/56 4/56 8/56 12/56 1/57 4/57 8/57 12/57 1/58 4/58 8/58 12/58 1/59 4/59 8/59 12/59 1/60 4/60 8/60 12/60 1/61 4/61 8/61 12/61 1/62 4/62 8/62 12/62 1/63 4/63 8/63 12/63 1/64 4/64 8/64 12/64 1/65 4/65 8/65 12/65 1/66 4/66 8/66 12/66 1/67 4/67 8/67 12/67 1/68 4/68 8/68 12/68 1/69 4/69 8/69 12/69 1/70 4/70 8/70 12/70 1/71 4/71 8/71 12/71 1/72 4/72 8/72 12/72 1/73 4/73 8/73 12/73 1/74 4/74 8/74 12/74 1/75 4/75 8/75 12/75 1/76 4/76 8/76 12/76 1/77 4/77 8/77 12/77 1/78 4/78 8/78 12/78 1/79 4/79 8/79 12/79 1/80 4/80 8/80 12/80 1/81 4/81 8/81 12/81 1/82 4/82 8/82 12/82 1/83 4/83 8/83 12/83 1/84 4/84 8/84 12/84 1/85 4/85 8/85 12/85 1/86 4/86 8/86 12/86 1/87 4/87 8/87 12/87 1/88 4/88 8/88 12/88 1/89 4/89 8/89 12/89 1/90 4/90 8/90 12/90 1/91 4/91 8/91 12/91 1/92 4/92 8/92 12/92 1/93 4/93 8/93 12/93 1/94 4/94 8/94 12/94 1/95 4/95 8/95 12/95 1/96 4/96 8/96 12/96 1/97 4/97 8/97 12/97 1/98 4/98 8/98 12/98 1/99 4/99 8/99 12/99 1/100 4/100 8/100 12/100 1/101 4/101 8/101 12/101 1/102 4/102 8/102 12/102 1/103 4/103 8/103 12/103 1/104 4/104 8/104 12/104 1/105 4/105 8/105 12/105 1/106 4/106 8/106 12/106 1/107 4/107 8/107 12/107 1/108 4/108 8/108 12/108 1/109 4/109 8/109 12/109 1/110 4/110 8/110 12/110 1/111 4/111 8/111 12/111 1/112 4/112 8/112 12/112 1/113 4/113 8/113 12/113 1/114 4/114 8/114 12/114 1/115 4/115 8/115 12/115 1/116 4/116 8/116 12/116 1/117 4/117 8/117 12/117 1/118 4/118 8/118 12/118 1/119 4/119 8/119 12/119 1/120 4/120 8/120 12/120 1/121 4/121 8/121 12/121 1/122 4/122 8/122 12/122 1/123 4/123 8/123 12/123 1/124 4/124 8/124 12/124 1/125 4/125 8/125 12/125 1/126 4/126 8/126 12/126 1/127 4/127 8/127 12/127 1/128 4/128 8/128 12/128 1/129 4/129 8/129 12/129 1/130 4/130 8/130 12/130 1/131 4/131 8/131 12/131 1/132 4/132 8/132 12/132 1/133 4/133 8/133 12/133 1/134 4/134 8/134 12/134 1/135 4/135 8/135 12/135 1/136 4/136 8/136 12/136 1/137 4/137 8/137 12/137 1/138 4/138 8/138 12/138 1/139 4/139 8/139 12/139 1/140 4/140 8/140 12/140 1/141 4/141 8/141 12/141 1/142 4/142 8/142 12/142 1/143 4/143 8/143 12/143 1/144 4/144 8/144 12/144 1/145 4/145 8/145 12/145 1/146 4/146 8/146 12/146 1/147 4/147 8/147 12/147 1/148 4/148 8/148 12/148 1/149 4/149 8/149 12/149 1/150 4/150 8/150 12/150 1/151 4/151 8/151 12/151 1/152 4/152 8/152 12/152 1/153 4/153 8/153 12/153 1/154 4/154 8/154 12/154 1/155 4/155 8/155 12/155 1/156 4/156 8/156 12/156 1/157 4/157 8/157 12/157 1/158 4/158 8/158 12/158 1/159 4/159 8/159 12/159 1/160 4/160 8/160 12/160 1/161 4/161 8/161 12/161 1/162 4/162 8/162 12/162 1/163 4/163 8/163 12/163 1/164 4/164 8/164 12/164 1/165 4/165 8/165 12/165 1/166 4/166 8/166 12/166 1/167 4/167 8/167 12/167 1/168 4/168 8/168 12/168 1/169 4/169 8/169 12/169 1/170 4/170 8/170 12/170 1/171 4/171 8/171 12/171 1/172 4/172 8/172 12/172 1/173 4/173 8/173 12/173 1/174 4/174 8/174 12/174 1/175 4/175 8/175 12/175 1/176 4/176 8/176 12/176 1/177 4/177 8/177 12/177 1/178 4/178 8/178 12/178 1/179 4/179 8/179 12/179 1/180 4/180 8/180 12/180 1/181 4/181 8/181 12/181 1/182 4/182 8/182 12/182 1/183 4/183 8/183 12/183 1/184 4/184 8/184 12/184 1/185 4/185 8/185 12/185 1/186 4/186 8/186 12/186 1/187 4/187 8/187 12/187 1/188 4/188 8/188 12/188 1/189 4/189 8/189 12/189 1/190 4/190 8/190 12/190 1/191 4/191 8/191 12/191 1/192 4/192 8/192 12/192 1/193 4/193 8/193 12/193 1/194 4/194 8/194 12/194 1/195 4/195 8/195 12/195 1/196 4/196 8/196 12/196 1/197 4/197 8/197 12/197 1/198 4/198 8/198 12/198 1/199 4/199 8/199 12/199 1/200 4/200 8/200 12/200 1/201 4/201 8/201 12/201 1/202 4/202 8/202 12/202 1/203 4/203 8/203 12/203 1/204 4/204 8/204 12/204 1/205 4/205 8/205 12/205 1/206 4/206 8/206 12/206 1/207 4/207 8/207 12/207 1/208 4/208 8/208 12/208 1/209 4/209 8/209 12/209 1/210 4/210 8/210 12/210 1/211 4/211 8/211 12/211 1/212 4/212 8/212 12/212 1/213 4/213 8/213 12/213 1/214 4/214 8/214 12/214 1/215 4/215 8/215 12/215 1/216 4/216 8/216 12/216 1/217 4/217 8/217 12/217 1/218 4/218 8/218 12/218 1/219 4/219 8/219 12/219 1/220 4/220 8/220 12/220 1/221 4/221 8/221 12/221 1/222 4/222 8/222 12/222 1/223 4/223 8/223 12/223 1/224 4/224 8/224 12/224 1/225 4/225 8/225 12/225 1/226 4/226 8/226 12/226 1/227 4/227 8/227 12/227 1/228 4/228 8/228 12/228 1/229 4/229 8/229 12/229 1/230 4/230 8/230 12/230 1/231 4/231 8/231 12/231 1/232 4/232 8/232 12/232 1/233 4/233 8/233 12/233 1/234 4/234 8/234 12/234 1/235 4/235 8/235 12/235 1/236 4/236 8/236 12/236 1/237 4/237 8/237 12/237 1/238 4/238 8/238 12/238 1/239 4/239 8/239 12/239 1/240 4/240 8/240 12/240 1/241 4/241 8/241 12/241 1/242 4/242 8/242 12/242 1/243 4/243 8/243 12/243 1/244 4/244 8/244 12/244 1/245 4/245 8/245 12/245 1/246 4/246 8/246 12/246 1/247 4/247 8/247 12/247 1/248 4/248 8/248 12/248 1/249 4/249 8/249 12/249 1/250 4/250 8/250 12/250 1/251 4/251 8/251 12/251 1/252 4/252 8/252 12/252 1/253 4/253 8/253 12/253 1/254 4/254 8/254 12/254 1/255 4/255 8/255 12/255 1/256 4/256 8/256 12/256 1/257 4/257 8/257 12/257 1/258 4/258 8/258 12/258 1/259 4/259 8/259 12/259 1/260 4/260 8/260 12/260 1/261 4/261 8/261 12/261 1/262 4/262 8/262 12/262 1/263 4/263 8/263 12/263 1/264 4/264 8/264 12/264 1/265 4/265 8/265 12/265 1/266 4/266 8/266 12/266 1/267 4/267 8/267 12/267 1/268 4/268 8/268 12/268 1/269 4/269 8/269 12/269 1/270 4/270 8/270 12/270 1/271 4/271 8/271 12/271 1/272 4/272 8/272 12/272 1/273 4/273 8/273 12/273 1/274 4/274 8/274 12/274 1/275 4/275 8/275 12/275 1/276 4/276 8/276 12/276 1/277 4/277 8/277 12/277 1/278 4/278 8/278 12/278 1/279 4/279 8/279 12/279 1/280 4/280 8/280 12/280 1/281 4/281 8/281 12/281 1/282 4/282 8/282 12/282 1/283 4/283 8/283 12/283 1/284 4/284 8/284 12/284 1/285 4/285 8/285 12/285 1/286 4/286 8/286 12/286 1/287 4/287 8/287 12/287 1/288 4/288 8/288 12/288 1/289 4/289 8/289 12/289 1/290 4/290 8/290 12/290 1/291 4/291 8/291 12/291 1/292 4/292 8/292 12/292 1/293 4/293 8/293 12/293 1/294 4/294 8/294 12/294 1/295 4/295 8/295 12/295 1/296 4/296 8/296 12/296 1/297 4/297 8/297 12/297 1/298 4/298 8/298 12/298 1/299 4/299 8/299 12/299 1/300 4/300 8/300 12/300 1/301 4/301 8/301 12/301 1/302 4/302 8/302 12/302 1/303 4/303 8/303 12/303 1/304 4/304 8/304 12/304 1/305 4/305 8/305 12/305 1/306 4/306 8/306 12/306 1/307 4/307 8/307 12/307 1/308 4/308 8/308 12/308 1/309 4/309 8/309 12/309 1/310 4/310 8/310 12/310 1/311 4/311 8/311 12/311 1/312 4/312 8/312 12/312 1/313 4/313 8/313 12/313 1/314 4/314 8/314 12/314 1/315 4/315 8/315 12/315 1/316 4/316 8/316 12/316 1/317 4/317 8/317 12/317 1/318 4/318 8/318 12/318 1/319 4/319 8/319 12/319 1/320 4/320 8/320 12/320 1/321 4/321 8/321 12/321 1/322 4/322 8/322 12/322 1/323 4/323 8/323 12/323 1/324 4/324 8/324 12/324 1/325 4/325 8/325 12/325 1/326 4/326 8/326 12/326 1/327 4/327 8/327 12/327 1/328 4/328 8/328 12/328 1/329 4/329 8/329 12/329 1/330 4/330 8/330 12/330 1/331 4/331 8/331 12/331 1/332 4/332 8/332 12/332 1/333 4/333 8/333 12/333 1/334 4/334 8/334 12/334 1/335 4/335 8/335 12/335 1/336 4/336 8/336 12/336 1/337 4/337 8/337 12/337 1/338 4/338 8/338 12/338 1/339 4/339 8/339 12/339 1/340 4/340 8/340 12/340 1/341 4/341 8/341 12/341 1/342 4/342 8/342 12/342 1/343 4/343 8/343 12/343 1/344 4/344 8/344 12/344 1/345 4/345 8/345 12/345 1/346 4/346 8/346 12/346 1/347 4/347 8/347 12/347 1/348 4/348 8/348 12/348 1/349 4/349 8/349 12/349 1/350 4/350 8/350 12/350 1/351 4/351 8/351 12/351 1/352 4/352 8/352 12/352 1/353 4/353 8/353 12/353 1/354 4/354 8/354 12/354 1/355 4/355 8/355 12/355 1/356 4/356 8/356 12/356 1/357 4/357 8/357 12/357 1/358 4/358 8/358 12/358 1/359 4/359 8/359 12/359 1/360 4/360 8/360 12/360 1/361 4/361 8/361 12/361 1/362 4/362 8/362 12/362 1/363 4/363 8/363 12/363 1/364 4/364 8/364 12/364 1/365 4/365 8/365 12/365 1/366 4/366 8/366 12/366 1/367 4/367 8/367 12/367 1/368 4/368 8/368 12/368 1/369 4/369 8/369 12/369 1/370 4/370 8/370 12/370 1/371 4/371 8/371 12/371 1/372 4/372 8/372 12/372 1/373 4/373 8/373 12/373 1/374 4/374 8/374 12/374 1/375 4/375 8/375 12/375 1/376 4/376 8/376 12/376 1/377 4/377 8/377 12/377 1/378 4/378 8/378 12/378 1/379 4/379 8/379 12/379 1/380 4/380 8/380 12/380 1/381 4/381 8/381 12/381 1/382 4/382 8/382 12/382 1/383 4/383 8/383 12/383 1/384 4/384 8/384 12/384 1/385 4/385 8/385 12/385 1/386 4/386 8/386 12/386 1/387 4/387 8/387 12/387 1/388 4/388 8/388 12/388 1/389 4/389 8/389 12/389 1/390 4/390 8/390 12/390 1/391 4/391 8/391 12/391 1/392 4/392 8/392 12/392 1/393 4/393 8/393 12/393 1/394 4/394 8/394 12/394 1/395 4/395 8/395 12/395 1/396 4/396 8/396 12/396 1/397 4/397 8/397 12/397 1/398 4/398 8/398 12/398 1/399 4/399 8/399 12/399 1/400 4/400 8/400 12/400 1/401 4/401 8/401 12/401 1/402 4/402 8/402 12/402 1/403 4/403 8/403 12/403 1/404 4/404 8/404 12/404 1/405 4/405 8/405 12/405 1/406 4/406 8/406 12/406 1/407 4/407 8/407 12/407 1/408 4/408 8/408 12/408 1/409 4/409 8/409 12/409 1/410 4/410 8/410 12/410 1/411 4/411 8/411 12/411 1/412 4/412 8/412 12/412 1/413 4/413 8/413 12/413 1/414 4/414 8/414 12/414 1/415 4/415 8/415 12/415 1/416 4/416 8/416 12/416 1/417 4/417 8/417 12/417 1/418 4/418 8/418 12/418 1/419 4/419 8/419 12/419 1/420 4/420 8/420 12/420 1/421 4/421 8/421 12/421 1/422 4/422 8/422 12/422 1/423 4/423 8/423 12/423 1/424 4/424 8/424 12/424 1/425 4/425 8/425 12/425 1/426 4/426 8/426 12/426 1/427 4/427 8/427 12/427 1/428 4/428 8/428 12/428 1/429 4/429 8/429 12/429 1/430 4/430 8/430 12/430 1/431 4/431 8/431 12/431 1/432 4/432 8/432 12/432 1/433 4/433 8/433 12/433 1/434 4/434 8/434 12/434 1/435 4/435 8/435 12/435 1/436 4/436 8/436 12/436 1/437 4/437 8/437 12/437 1/438 4/438 8/438 12/438 1/439 4/439 8/439 12/439 1/440 4/440 8/440 12/440 1/441 4/441 8/441 12/441 1/442 4/442 8/442 12/442 1/443 4/443 8/443 12/443 1/444 4/444 8/444 12/444 1/445 4/445 8/445 12/445 1/446 4/446 8/446 12/446 1/447 4/447 8/447 12/447 1/448 4/448 8/448 12/448 1/449 4/449 8/449 12/449 1/450 4/450 8/450 12/450 1/451 4/451 8/451 12/451 1/452 4/452 8/452 12/452 1/453 4/453 8/453 12/453 1/454 4/454 8/454 12/454 1/455 4/455 8/455 12/455 1/456 4/456 8/456 12/456 1/457 4/457 8/457 12/457 1/458 4/458 8/458 12/458 1/459 4/459 8/459 12/459 1/460 4/460 8/460 12/460 1/461 4/461 8/461 12/461 1/462 4/462 8/462 12/462 1/463 4/463 8/463 12/463 1/464 4/464 8/464 12/464 1/465 4/465 8/465 12/465 1/466 4/466 8/466 12/466 1/467 4/467 8/467 12/467 1/468 4/468 8/468 12/468 1/469 4/469 8/469 12/469 1/470 4/470 8/470 12/470 1/471 4/471 8/471 12/471 1/472 4/472 8/472 12/472 1/473 4/473 8/473 12/473 1/474 4/474 8/474 12/474 1/475 4/475 8/475 12/475 1/476 4/476 8/476 12/476 1/477 4/477 8/477 12/477 1/478 4/478 8/478 12/478 1/479 4/479 8/479 12/479 1/480 4/480 8/480 12/480 1/481 4/481 8/481 12/481 1/482 4/482 8/482 12/482 1/483 4/483 8/483 12/483 1/484 4/484 8/484 12/484 1/485 4/485 8/485 12/485 1/486 4/486 8/486 12/486 1/487 4/487 8/487 12/487 1/488 4/488 8/488 12/488 1/489 4/489 8/489 12/489 1/490 4/490 8/490 12/490 1/491 4/491 8/491 12/491 1/492 4/492 8/492 12/492 1/493 4/493 8/493 12/493 1/494 4/494 8/494 12/494 1/495 4/495 8/495 12/495 1/496 4/496 8/496 12/496 1/497 4/497 8/497 12/497 1/498 4/498 8/498 12/498 1/499 4/499 8/499 12/499 1/500 4/500 8/500 12/500 1/501 4/501 8/501 12/501 1/502 4/502 8/502 12/502 1/503 4/503 8/503 12/503 1/504 4/504 8/504 12/504 1/505 4/505 8/505 12/505 1/506 4/506 8/506 12/506 1/507 4/507 8/507 12/507 1/508 4/508 8/508 12/508 1/509 4/509 8/509 12/509 1/510 4/510 8/510 12/510	

.....: اسم المريض رباعي
.....: الرقم الطبي الموحد



وزارة الصحة و السكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام "هرمل"
ادارة الجودة

Doctor's Orders الاوامر الطبيب

.....: التشخيص: نوع التغذية

التاريخ	الوقت	الأوامر	توقيع الطبيب
13/10/2022	22:00	* C.I.O. - G.II. Diarrhea, G.II. Nausea, vomiting. - No ↑ in Bowel. Bilat. LL Neuropathy G.I. * MRI Pelvis [21/10/2022]: Normal. * Fac. - C3.w2 Taxol 125mg 1Carbo. AUC: [2] - C3.w3 Taxol 125mg 1Carbo. AUC: [2] - Contraloc 40mg Tab. 1x1x 14 days - Em-Ex Tab. 2x2x 10 days - Hydraloc Tab. 1x2x 10 days	* subjective ↓ in LL Breast Mass size: * O/E: Mobile LL axillary LN ~1cm small Rt. Breast Mass ~1.5cm
20/10/2022	13:00	PH/AHMED NAHER C3W2TC 13/10/2022 د. أحمد ناهر 13/10/2022 C3W3 TC 250mg 11/10/22	

جميع الأوامر الطبية لابد أن تكون واضحة وموقعة من الطبيب



Age 54 yrs

wt 65

Ht 155

S.A1.67

ABW 54.7

S.Cv.04 → 0.7

crcl 79.33

Canula site (208)

وزارت صحت و خاندان
امدادی مراکز طبیہ المتخصصہ
ہسپتالی اور ددرالسلام "نرمز"

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

زوداً ارم + ارم + ارم + ارم + ارم
تحتوى (10) مع 1000
كاربواميد 200
برم 100
هرم 100
خارج زرع
توقيع الطبيب سراج
الحمد يوم 10/11/2022

C.Ph/Aya Diau

27/10/2022

TC/HP

التاريخ:
الوقت:

wt 65

(208 mg)

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

C.CC 10/10

Arden

اسبوعين

C.Ph/Aya Diau

3/11/2022

wt 65 (208 mg)

C.C

/ / التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب :



Dr. Sherif H.

وزارة الصحة والسكان
أمانة المركز الطبي المتخصص
أورام دار السلام
(شغل سابقاً)
إدارة الجردة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

10 / 11 / 2022

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر Carboplatin AUC 2

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

125 mg T4 ml

Contra 100 Lx1

Contra 100 Lx1

Neuro 100 Lx2

Throat 600 Lx2

توقيع الطبيب :

1 / 1 التاريخ :
أوقات : Doktor 100 Lx3

Mucosa 100 Lx2

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

100 mg 100 Lx3 11/11

Contra 100 Lx1

Contra 100 Lx1

W2 TC (209-9)

Chp H. H. H.

10/11

MN, pd 11/11
free

توقيع الطبيب :

1 / 1 التاريخ :
الوقت :



Age 54

wt 65

Ht 1.55

BSA 1.6

→ ABWL SL 17

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام

(شمل سابقاً)

إدارة الموردة

??

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Disappe h Breast mas
4 still felt axillary LN.

w/6 Taxol 4 Carbop 4 Hap CS

w/6 R/Taxol 12s → 500mL / 4h

R/Carbop 400mg

R/Horaph 600mg CS Phes 90

R/Herceptin 4200mg IV

R/Emax 1x 2 RSDay

R/Emax 2 4x 2 RSDay

R/newton 1x 130

Canula site infection:

w/6 Taxol 4 Carbop 4 Hap CS

10/10

w/6 TC (209)

14/12
2022

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:



وزارة الصحة والسكان
إمارة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

22/12/2022

for W18 TC

+ MDT

توقيع الطبيب : د. محمد بن محمد

التاريخ: / /

الوقت:

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

29/12/2022

for C6 H/p.

12
توقيع الطبيب : د. محمد بن محمد

التاريخ: / /

الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمل)
الصيدلة الإكلينيكية

[MBC] >> Paclitaxel/Carboplatin AUC 5 + Trastuzumab
Protocol Cycle (.....)

اليوم: الخبيث		التاريخ: 2022/12/22	
اسم المريض: محمد عبد الله		رقم الملف:	
Weight: kg	Height: cm	BSA: M2	Age: years
CBC:	WBC:	ANC:	Hgb: PLT:
Functions Tests:	Sr.Creat:	Urea:	CrCL:
	ALT:	AST:	T.Bil: D.Bil:
Echo:	Date: 8/12	EF: 66%	
Dose Modification: %			
Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:			
الصرف	بروتوكول العلاج	امضاء التمريض	
19/12	جرانيسيترون (0.01 مجم/كجم) مجم + ديكساميثازون 20 مجم + انتودين 20 مجم + امبول افيل في 50 مل ج 5% علي مدي ربع ساعة قبل العلاج الكيماوي. (Maximum dose of Granisetron = 1mg)		
19/12	تراستوزوماب علي 250 مل ملح لمدة نصف ساعة (علي 500 مل ملح لمدة ساعة ونصف الجرعة الاولى فقط) Loading Dose: 8 mg/m ² Maintenance Dose: 6 mg/m ² (MAX: 440 mg)	next week	
19/12	باكليتاكسل (175 مجم/م ²) مجم في 500 مل ج 5% علي مدي ساعة		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
19/12	كاربوبلاتين (AUC 2) مجم في 500 مل ج 5% علي ساعة.		
	50 مل ج/ملح علي مدي 10 دقائق		
العلاج التدايمي:			
كونترولوك قرص 40 مجم علي الريق لمدة اسبوع. C1X1X1 ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) كل 12 ساعة لمدة 3 ايام تبدأ اليوم السابق للجرعة. ايمند قرص 125 مجم اليوم الاول و 80 مجم اليوم الثاني و الثالث. - شيرينيت 3-X1X1 - يا ر امبول 2-X2X2 - حوتيلون 7-X2X1 - فيسر الجسيم 7-X2X1			
Physician Signature:	Clinical pharmacy:	Dispensing pharmacy:	
د. محمد	Ph/Aya Ncum 22/12/2022	T.C (208) 18	



Dr. H. H.

11

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

Dr. H. H.

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

practically 4/20 any

the patient 600 any

دار السلام
C. 41 / 1 / 19
C. 44 / 1 / 19
C. 45 / 1 / 19

توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:

C6HP
Cl. ph. 1/19
29/12/2022

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

R. methyl technia

لترعة على الدم لمتبر

التاريخ: 1/19
الوقت: 1/19

توقيع الطبيب :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

chest:
Temp: ER 018 - PR 418
Oral mucositis:
Canula site infection: 218.

- Cg. phesgo SC

- nolvadex 10 mg 1 X 2 X 90 21

Cg phesgo
Cl. ph. / Phesgo
28/2/2023

التاريخ: / /
الوقت:

توقيع الطبيب: د. / /
C - 02.10/28

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

Cg

Cg phesgo

Cl. ph.
Phesgo

Cg phesgo

التاريخ: / /
الوقت:

توقيع الطبيب:
C - 02.10/28



وزارة الصحة والسكان
إدارة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

chest: EF 63% in 13/4/2023
Temp: 37.5
Oral mucositis: no
Canula site infection: no

7-7-2023

3. Xcxi -

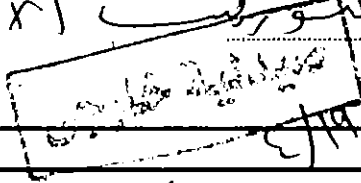
2. Xcxi -

1. Xcxi -

2. Xcxi -

توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:



الأوامر

chest: no
Temp: 37.5
Oral mucositis: no
Canula site infection: no

Clophesgo
19/4/2023
Ph/AHMED

7-7-2023

3. Xcxi -

2. Xcxi -

1. Xcxi -

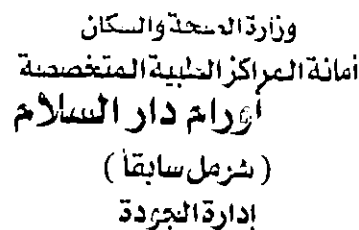
2. Xcxi -

توقيع الطبيب :

التاريخ:
الوقت:

Clophesgo
16/5
Mout Red

7-7-2023



اسم المريض : حميد عبد الباقي
الرقم الطبي : 9999999999

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Cannula site infection:

Handwritten notes on lined paper:

Top left: C12

Top right: C12

Main body text (crossed out with a large X):

ماوراء النهر - ٢١ / ٦ - ٣١ / ٧
تاريخ الميلاد :
الاسم :
العنوان :
رقم الهاتف :

Bottom right: توقيع الطبيب :

Bottom center: دكتور وادان محمد علي

Bottom left: التاريخ :
الوقت :

མགོན་པོ་འབྲུག་པོ།

سارے

0/51

chest:			
Temp:			
Oral mucositis:			
Canula site infection:			

Canula site infection.....3.....

.....

22

500

.....

— 30 —

```
-----
```

[illegible]

3

التاريخ: / /

الموقت:

ج - فیلو - ی، کد

احولہ ص ۲۰۷

726

١٠٠

عدد کل صفحات کتاب (۱۰)

سَمَاءُ لَيْلِي

تم الطيب : د. عبد الله بن عبد الله

C. 21/9/21

$C_{13} \text{Phenyl} =$

محمد اسد

1-97/c1

1

1

اسم المريض ثلاثي: كريمة محمد
رقم الملف: ٢٠٢٢/١٠٠٠



وزارة الصحة و السكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام " هرمل "

إقرار الموافقة على علاج كيميائي

أقرنا..... ولي أمر الطفل..... الرقم القومي:.....

بأنني قد وافقت على تلقي العلاج الكيميائي لعلاج مرض:

كما أقر بأنني تلقيت شرح شامل ما يلي: -

- طبيعة العلاج الكيميائي المقدم وطرق تلقي العلاج.

- الفوائد المرجوة من العلاج الكيميائي ومدى احتمالية نجاحه.

- المخاطر والمضاعفات المحتملة لتلقي العلاج الكيميائي التي قد تشمل الغثيان والقيء، تساقط الشعر،

الإمساك، الإحساس بالإرهاق، التهابات الفم والجهاز الهضمي، ضعف المناعة، أنيميا، التهاب المثانة،

هشاشة العظام، تأثير وظائف الكلى-الكبد-القلب، العقم عند الذكور ، اضطرابات التبويض عند الإناث.

- البدائل المتاحة للعلاج الكيميائي إن وجدت.

- العواقب المحتملة في حالة رفض العلاج الكيميائي.

وهذا إقرار مني بذلك دون أنني مسئولية على الطبيب أو الطاقم الطبي.

أقر بهذا وأوقع عليه

توقيع ولي أمر الطفل: كريمة محمد صلة القرابة: أم

اسم الطبيب: د. أحمد عبد الله التوقيع: د. أحمد عبد الله

اسم الشاهد: محمد التوقيع: محمد

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٥ الوقت: ١٥:٠٠

ملحوظة: يتم تغيير الإقرار عند تغيير بروتوكول العلاج



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض : صبره محمد عبد الله
الرقم الطبي : ٢٩٩/٢٩

الأوامر

chest: _____
Temp: _____
Oral mucositis: _____
Canula site infection: _____

صيدلية خارجي

12/1/6/25

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:

الأوامر

chest: _____
Temp: _____
Oral mucositis: _____
Canula site infection: _____

EF.61.t.

صيدلية خارجي
12/1/6/25

صيدلية خارجي

1/8/25

صيدلية الخارج

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:



وزارة الصحة والسكان
إسناد المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شربل سابقاً)
إدارة الجودة

EF (1/8/2023) = 61 %

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض:
الرقم الطبي: ٢٩٢٢/٢٩

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

23/8/2023 Cycle (16)

م. ج. ٢٦ ك. الخلد

ت. كامل وشم ١٠٠ ق.م. يوم ١

ت. كامل وشم ١٠٠ ق.م. يوم ٢

براقول ٢٠ ق.م. يوم ٣

ت. كامل وشم ١٠٠ ق.م. يوم ٤

توقيع الطبيب:

ك. خلد

C16 ph.

٢٩٢٢/٨/٢٣

٢٩٢٢/٨/٢٣

صيدلية خارجي
التاريخ: ٢٣/٨/٢٣
الوقت: ١٢:٠٠

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

ف. خلد وشم ١٠٠ ق.م. يوم ١

ت. كامل وشم ١٠٠ ق.م. يوم ٢

ت. كامل وشم ١٠٠ ق.م. يوم ٣

ت. كامل وشم ١٠٠ ق.م. يوم ٤

C17 phesgo

١٢/٩

١٢/٩

توقيع الطبيب:

م. خلد

٢٩٢٢/٩/١٣

٢٩٢٢/٩/١٣



وزارة الصحة والشؤون
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شامل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض: هبة السيد عبد الباسط

الرقم الطبي: ٢٩٠٣/٢٢

الأوامر

chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Abulul - Free

BW BB Mmm - -

Free

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

توقيع الطبيب: ١٩/٢ مريض

التاريخ:

الوقت:

٢٢٢/١٢/١٣

أوامر الطبيب

chest:

Temp: ٣٨.٥

Oral mucositis:

Canula site infection:

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

١٩/٢ مريض

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب: ١٩/٢ مريض



وزارة الصحة والسكان
إسناد المراكز الطبية المتخصصة
أوامر دار السلام
(شربل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :
2952/CC

الأوامر
22/07
2952/CC

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

توقيع الطبيب :
الأوامر
2952/CC
22/07
2952/CC

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

الأوامر
2952/CC
22/07
2952/CC

2952/CC
22/07
2952/CC

توقيع الطبيب :
التاريخ :
الوقت :

وزارة
الصحة العامة

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

Dr. Amr

Section

Dr. Amr

صحة عند الزد

Section

صحة عند الزد

توقيع

التاريخ: ١٢/١٢
الوقت:

Dr. Amr

توقيع الطبيب

الأوامر

S:

Section

Dr. Amr

صحة عند الزد

صحة عند الزد

صحة عند الزد

صحة عند الزد

صحة عند الزد

صحة عند الزد

توقيع

التاريخ: ١٢/١٢
الوقت:

توقيع الطبيب



بإمارة الصحة والكان
أكز الطبية المتخصصه
أوامر دار السلام
شربل سابقاً
إدارة البندوة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

يضم :

طبيب :

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

Break G under Adj. h. 1#

Build STM →

التاريخ:

الوقت:

الطبيب :
(1) كاشف
(2) شربل

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

حاشية :
بناو (1)
و (2) ل (1)

أ. طبيب :
الشربل (1)

التاريخ:

الوقت:

الطبيب :



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
أورام دار السلام
(شمل سابقاً)
إدارة الجودة

أوامر الطبيب Doctor's Orders

اسم المريض : حميدة سيد عبدالباق
الرقم الطبي :

الأوامر

chest: ON EX.
Temp: NAD
Oral mucositis:
Canula site infection:

تامولسفين ٢٠٠

٦ ليوم

١٠٠٠ مل ماء

٢٠٠٠ مل ماء

توقيع الطبيب :

مرو ٢٠٠٠

التاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٥
الوقت :

الأوامر

chest:
Temp:
Oral mucositis:
Canula site infection:

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

١٠/١٢/٢٠١٥

توقيع الطبيب :

التاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٥
الوقت :

١٠/١٢/٢٠١٥



حميدة محمد عبد الباق

Deen sir,

May I kindly refer to you this 55 year old female pt. with left Br. cancer who received 18 wks neoadjuvant of Taxol-Carbo + P+H that ended on 22/12/2022, then underwent left MRM on 12/1/2023 & was referred to W for PORT.

Started: 6/4/2023

Ended: 29/4/2023

Received, 40 Gy / 15fx / 3 wks

ط/م/أيتن ط/أ خلد

29/4/2023